UNIVERSITÉ CÔTE D'AZUR
FACULTÉ DE MÉDECINE

TUT'ECOS

Réanimation

Sujet 5 : Céphalée en coup de tonnerre

sans patient

sans geste clinique

Nom du rédacteur : GIRONE Luca Date de rédaction : 27/11/23

Relecture intra-ou transdisciplinaire :

Situation de départ : Céphalée SDD-118

Domaine de compétence principal : Entretien

Domaine de compétence secondaire : Analyse d'examen complémentaire, orientation diagnostique et prise en charge

Attendus d'apprentissage de la situation abordée (cf. LISA : Catégorie:Situation de départ NG — LiSA (uness.fr)**):**

1 - Connaître les modalités du diagnostic d'une céphalée aiguë et d'une céphalée chronique OIC-100-01-A

2- Énoncer les principales causes de céphalée aiguë et les caractéristiques cliniques propres à chacune OIC-100-03-A

3- Savoir mettre en route un traitement des céphalées aux urgences OIC-100-07-A

Objectifs de la station (items de connaissances abordés) :

1. Connaître les modalités du diagnostic d'une céphalée aiguë et d'une céphalée chronique OIC-100-01-A
2. Connaître les principales causes de céphalées nécessitant une prise en charge en urgence et leur présentation clinique OIC-100-02-A
3. Énoncer les principales causes des céphalées récentes d'aggravation progressive et les caractéristiques cliniques propres à chacune OIC-100-05-A
4. Savoir mettre en route un traitement des céphalées aux urgences OIC-100-07-A

Patient simulé nécessaire à la station : NON

Matériel nécessaire à la station

- Mannequin NON
- Brancard NON

Instructions à l'étudiant

Vous êtes interne de réanimation de garde aux urgences et un patient de 28 ans vient pour des céphalées en coup de tonnerre.
Dans ses antécédents il vous notifie avoir une polykystose rénale :

Vous avez **8 minutes** pour :

1) Décrire l'examen d'imagerie
2) Enoncer les signes de gravité à rechercher
3) Donner la cause la plus fréquente, votre orientation diagnostique ainsi que la prise en charge précoce et tardive

UNIVERSITÉ CÔTE D'AZUR
FACULTÉ DE MÉDECINE

TUT'ECOS

Fiche de correction pour l'évaluateur (sans le barème)

	Cocher si fait
Tache 1: Q1 Décrire l'examen d'imagerie	
Scanner cérébral	ok/1
Sans injection	ok/1
En coupe axiale/horizontale/transversale	ok/1
Hyperdensité spontanée des espaces méningées/sous arachnoïdiens gauches	ok/1
Tache 2 : Q2 Enoncer les signes de gravité à rechercher	
Trouble de la conscience (Glasgow<15)	/1
Signe d'engagement cérébral (mydriase aréactive, paralysie, arrêt cardiaque…)	/1
Déficit neurologique	/1
Tache 2 : Q3 Donner la cause la plus fréquente, votre orientation diagnostique ainsi que la prise en charge pour ce type de céphalée	
Cause la plus fréquente énoncée : Rupture de malformation vasculaire cérébrale/Rupture d'anévrisme	/1
Orientation diagnostique énoncée : Hémorragie méningée/Hémorragie sous arachnoïdienne	/1
Cite la prise en charge nécessaire en milieu spécialisé	/1
Cite la prise en charge symptomatique : prise en charge antalgique (médicament antalgique adapté au niveau de douleur et isolement sensoriel)	/1
Cite la prise en charge symptomatique : prise en charge de l'hypertension artérielle si présente et des ACSOS (SpO2, Hyperglycémie, Osmolarité plasmatique, Hyperthermie, Anémie)	/1
Cite la prise en charge étiologique si retrouvée (exclusion de l'anévrisme si retrouvé…)	/1
Cite la prise en charge des complications précoces (récidive hémorragique/resaignement, HTIC aigue, Hydrocéphalie, Autres)	/1
Cite la prise en charge des complications tardives (Ischémie cérébrale retardée, Hydrocéphalie chronique, Autres)	/1

UTILISER IMPERATIVEMENT DES VERBES d'ACTION ex : « Dit » « Énonce » « Palpe » « Écoute »

TUT'ECOS

SEPARER CHAQUE ITEM (ex : « recherche une consommation de tabac » et « quantifie une consommation de tabac » sont deux items différents)

MAXIMUM 15 Items de compétence spécifiques et 5 items de compétences génériques
Choisir les plus pertinents/discriminants

Fournir des schémas pour les points cliniques à évaluer par l'examinateur (cadrans d'examen abdominal, foyers d'auscultation etc.)

Préciser quand l'examinateur doit intervenir pour donner un signe clinique positif

UNIVERSITÉ CÔTE D'AZUR
FACULTÉ DE MÉDECINE

TUT'ECOS

Fiche de correction avec le barème : non communiqué à l'évaluateur

	Pondération (entre 1 et 5)
Tache 1	
Tache 2	
COMPETENCES GENERIQUES	
	Echelle de 1 à 5